



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**FEASIBILITY STUDY
ENDOSKOPI GASTROINTESTINAL
(PENAMBAHAN ATAU PENGEMBANGAN
PELAYANAN)
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang
Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com



**FEASIBILITY STUDY ENDOSKOPI GASTROINTESTINAL
(PENAMBAHAN ATAU PENGEMBANGAN PELAYANAN)
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2026**

A. LATAR BELAKANG

Pemeriksaan endoskopi gastrointestinal merupakan prosedur diagnostik dan terapeutik yang memungkinkan visualisasi langsung mukosa saluran cerna bagian atas maupun bawah. Dengan endoskopi, tenaga medis dapat mengidentifikasi sumber perdarahan, peradangan, ulkus, polip, keganasan, serta kelainan struktural lainnya secara lebih tepat dibandingkan pemeriksaan klinis dan penunjang non-invasif.

Selain sebagai alat diagnostik, endoskopi juga berperan penting dalam tindakan terapeutik, seperti pengendalian perdarahan, biopsi, polipektomi, dilatasi striktur, dan pengangkatan benda asing. Hal ini dapat mengurangi kebutuhan tindakan bedah dan menurunkan lama rawat inap.

Beberapa diagnosa klinis yang memerlukan pemeriksaan endoskopi diantaranya saluran Cerna Bagian Atas diantaranya adalah anemia, muntah persisten, hematemesis, melena, Gastritis erosive, Ulkus peptikum, Gastroesophageal reflux disease (GERD) dengan komplikasi, Disfagia dan odinofagia, Esofagitis (termasuk akibat refluks atau infeksi), Varises esofagus, Keganasan esofagus dan lambung dan lainnya. Selain itu, pemeriksaan endoskopi juga bisa dilakukan pada pasien dengan diagnosa perdarahan saluran cerna bawah hematochezia, darah samar pada feses, Diare kronik, Konstipasi kronik dengan tanda bahaya, Ulcerative colitis, Crohn's disease, Polip kolon dll.

Data rujukan pasien yang dirujuk pro endoskopi berdasarkan data rekam medis RS Prima Husada Malang bulan Januari-Desember 2025 sebanyak 45 pasien. Sedangkan jumlah pasien Bulan Januari-Desember tahun 2025 (rawat jalan dan rawat inap) dengan diagnosis yang berpotensi bisa dilakukan pemeriksaan Endoskopi sejumlah 2.681 pasien dengan rincian sebagai berikut :

1. GEA = 1.998
2. Dispepsia = 248
3. Gastritis = 186
4. GERD = 176
5. Hematemesis = 32
6. Melena = 23
7. Tumor colon = 18

Tidak semua rumah sakit tipe C memiliki alat endoskopi sehingga memberikan peluang yang tinggi agar RSPHM dapat menekan angka rujukan, dan meningkatkan kunjungan pasien baik dari internal maupun eksternal RS. Dengan pengadaan alat endoskopi yang kedepannya bisa untuk MOU dengan FKTP (klinik rawat inap, dokter umum dll) dan RS sekitar diharapkan dapat meningkatkan pendapatan RS terutama untuk penjamin umum dan asuransi non bpjs.



B. TUJUAN

Pengajuan Endoskopi Gastrointestinal mempunyai tujuan diantaranya :

1. Tujuan Diagnostik

- Menilai kondisi mukosa saluran cerna secara langsung
- Menentukan sumber perdarahan saluran cerna
- Menegakkan diagnosis penyakit saluran cerna (inflamasi, ulkus, polip, keganasan)
- Mengambil sampel jaringan (biopsi) untuk pemeriksaan histopatologi
- Mengevaluasi kelainan struktural (striktur, varises, massa, lesi)

2. Tujuan Terapeutik

- Mengendalikan perdarahan saluran cerna
- Melakukan polipektomi
- Mengangkat benda asing
- Melakukan dilatasi striktur
- Pemasangan atau pelepasan stent saluran cerna

3. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

- Memantau perkembangan penyakit saluran cerna kronis
- Menilai keberhasilan terapi
- Evaluasi pasca tindakan atau pasca operasi
- Pemantauan kekambuhan penyakit

4. Tujuan Pencegahan

- Skrining kanker saluran cerna (terutama kanker kolorektal)
- Deteksi dini lesi prakanker
- Mengurangi risiko komplikasi penyakit saluran cerna

C. MANFAAT

Alat Endoskopi gastrointestinal akan memberikan manfaat bagi dokter, pasien dan juga rumah sakit. Bagi dokter, dokter dapat menegakkan diagnosis penyakit saluran cerna secara akurat, menentukan sumber perdarahan saluran cerna dengan cepat, mendeteksi kelainan mukosa secara langsung, mengidentifikasi lesi dini dan keganasan saluran cerna. Bagi pasien, pasien dapat mendapatkan pelayanan yang cepat dan komprehensif diantaranya dapat mengendalikan perdarahan saluran cerna tanpa pembedahan, minimal tindakan invasif (biopsi, polipektomi, dilatasi), mengurangi kebutuhan tindakan bedah. Bagi Rumah Sakit, manfaatnya adalah memperpendek lama rawat inap karena mempercepat penegakan diagnosa pasien, mengurangi kesalahan diagnosis sehingga meningkatkan mutu dan layanan kesehatan pasien, menambah pendapatan rumah sakit karena kasus dengan diagnosa gastrointestinal (terutama untuk pasien BPJS kesehatan) dapat dikelola dengan baik sesuai PPK dan CP.



D. DATA PASIEN

Tabel 1. Jumlah Pasien dengan diagnosa yang berpotensi dan bisa dilakukan Pemeriksaan Endoskopi Gastrointestinal Januari – Desember 2025

NO	DIAGNOSA	Rawat jalan	Rawat Inap
1	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09)	1806	192
2	Dyspepsia (K30)	245	3
3	Gastritis (K25.7)	179	7
4	Gastro-oesophageal reflux disease (GERD) (K21)	172	4
5	Hematemesis (K92)	5	27
6	Melena (K92.1)	8	15
7	Tumor colon (C18)	14	4
TOTAL		2.429	252

Tabel 2. Jumlah Pasien yang dirujuk pro Endoskopi gastrointestinal

NO	UNIT	Jumlah Pasien Januari – Desember 2025
1	Rawat Jalan	32
2	Rawat Inap	13
TOTAL		45

D. JUMLAH SDM

Tabel 3. Jumlah SDM di Rumah Sakit Prima Husada Malang

Jenis SDM	Jumlah
Dokter Spesialis Penyakit Dalam terlatih Endoskopi (saat ini masih belum ada)	1
Perawat Endoskopi terlatih (saat ini masih belum ada)	1
Anestesi (bila diperlukan)	1



E. ANALISIS SITUASI

Internal

a. Kekuatan

1. RS Prima Husada Malang memiliki SDM yang cukup untuk pemanfaatan alat
2. Dukungan dari owner untuk mengembangkan pelayanan penunjang medis
3. Dengan alat endoskopi tersedia, diagnosis penyakit saluran cerna dapat ditegakkan secara langsung dan akurat, terutama pada kasus perdarahan saluran cerna dan kondisi gawat darurat
4. Alat endoskopi memungkinkan tidak hanya pemeriksaan diagnostik, tetapi juga tindakan terapeutik seperti biopsi, polipektomi, dan hemostasis, sehingga mengurangi kebutuhan pembedahan
5. Alat endoskopi mengurangi biaya rujukan dan transportasi pasien, serta berpotensi menurunkan lama rawat inap.

b. Kelemahan

1. Biaya pembelian sangat tinggi
2. Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Tinggi
3. Membutuhkan tenaga terlatih dan harus disekolahkan (Dokter IPD maupun perawat yang terampil endoskopi)

Eksternal

a. Peluang

1. Kasus diagnosa gastrointestinal yang membutuhkan pemeriksaan endoskopi bervariasi dan beragam sehingga pangsa pasar tinggi
2. Endoskopi memungkinkan program skrining kanker saluran cerna dan deteksi dini lesi prakanker, yang dapat meningkatkan outcome kesehatan masyarakat
3. Menjadi tempat rujukan dari Faskes atau RS yang belum memiliki Pemeriksaan Endoskopi, karena saat ini tidak semua RS tipe C mempunyai alat tersebut

b. Ancaman

1. Alat endoskopi memiliki biaya pembelian yang relatif mahal dibandingkan dengan peralatan medis lainnya, dengan pembelian alat baru, maka menjadi beban RS untuk setiap tahun ada biaya penyusutan alat medis.



G. RENCANA PENGAJUAN UNIT

Jenis : Endoskopi Gatrointestinal

Jumlah : 1 unit

Spesifikasi umum :

Nama Produk	Olympus GIF-N30 Gastroscope Endoscope
Masa Berlaku Produk	15 tahun
Merek	Olympus Corporation
No. Produk Penyedia	GIF-N30
Unit Pengukuran	unit
Jenis Produk	import
Nomor Izin Edar	-
Nama Perusahaan Sesuai NIE	PT Olympus Medical Indonesia
Nama Pabrik Sesuai NIE	PT Olympus Medical Indonesia
Model / Type	Olympus GIF-N30 Gastroscope Endoscope
Jenis Produk Sesuai Izin Edar	-
Fungsi	Gastroskop dari Olympus yang digunakan untuk pemeriksaan saluran pencernaan bagian atas (esofagus, lambung, dan duodenum)
Negara Asal Produk	Jepang
Negara Pabrikan	Jepang
Spesifikasi Produk Secara Singkat	• Diameter luar distal (Distal End OD): ~5,3 mm • Channel kerja (Instrument/Biopsy Channel): ~2,0 mm • Panjang kerja: Working length: ~93 cm, total length: ~125 cm • Bidang pandang (Field of View): $\approx 120^\circ$ • Jarak fokus (Depth of Field): 3 – 50 mm • Arah pandang: Forward view dengan sudut lihat yang luas



- Rentang manuver (Bending): Up: 210°,
Down: 90°, Right / Left: 100° / 100°

Rincian anggaran umum unit

NO	URAIAN	SATUAN	Jumlah (Rp)
Harga Perolehan Unit			
1		1 unit	Rp. 175.000.000

Rincian Anggaran operasional

Listrik dll.

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	Listrik/tahun	1. Listrik running 1 px : Rp. 24 2. Estimasi pertahun = 314 x Rp.24 = Rp 7.536

Rincian Pemeliharaan/tahun (MMEL)

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	Service + Spare Part / Tahun	Rp. 87.412.500

Biaya Penyusutan

NO	NAMA ALAT	MERK / TYPE	JUMLAH	HARGA	PENYUSUTAN (tanpa residu)	BIAYA PENYUSUTAN
1			1 UNIT	175.000.00 0	= Harga Perolehan : Usia Teknis = 175.000.000 : 15	11.666.667

G. ANALISIS KEUANGAN

NO	Hasil Endoskopi	RJ (Endoskopi)	RI (Kelas 3)
1	Esofagitis erosit	1.149.900	3.330.600
2	Gerd (Scoring GERD Minimal 8)	1.149.900	3.330.600
3	Gastritis	1.149.900	2.319.700
4	Gastric ulcer & duodenum	1.149.900	2.319.700
5	Varises Esofagus	1.149.900	3.330.600
6	Obstruksi Esofagus	1.149.900	3.330.600



Total Cost / Tahun

= biaya operasional + biaya pemeliharaan + biaya penyusutan
= Rp 7.536 + Rp. 87.412.500 + 11.666.667
= Rp. 99.086.703

Unit Cost

= Total Cost : Utilitas
= Rp. 99.086.703 : 314
= 315.562

Rencana Tarif

Tarif Umum (Margin 25%) = unit cost + 25%
= 394.453

Tarif BPJS Kesehatan = 362.897
(Margin 15%)

Tarif BPJS Ketenagakerjaan = 426.009
(Margin 35%)

Tarif Asuransi Lain = 441.787
(Margin 40%)



PENUTUP

Dengan pengadaan alat endoskopi yang memadai, diharapkan rumah sakit dapat menyediakan layanan yang cepat, aman, akurat, dan berstandar tinggi, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien, serta memperkuat posisi rumah sakit sebagai pusat layanan kesehatan unggulan.

Kepala Bagian Umum

drg. Endy Wira Pradana,
M.MRS

Ketua Tim HTA

dr. Arief Heru Wicaksono, Sp. An

Mengetahui,
Kepala Bidang Pelayanan
Medis

Puput Sekar Nari Ratih, Amd.
Keb

Menyetujui,
PLT Direktur
Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes